



RESUMO DE AULA · JORNADA DA LEITURA

Formulação de caso baseada em processos

CAPÍTULO 5

A habilidade que costura evidência, expertise e o paciente concreto. Da hipótese viva à análise de rede, e da rede ao plano de tratamento — com flexibilidade dentro da fidelidade.

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

Júlio Gonçalves

MSc · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

Comunidade Lógica Psicológica

Uma comunidade para quem quer:

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, com pensamento crítico e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas e construção em rede.

[Clique aqui e saiba mais](#)



O ESSENCIAL

- Ψ **Formulação de caso é habilidade treinável, não talento.** Ela se apoia nos três pilares da prática baseada em evidências — melhor evidência disponível, expertise clínica, e valores e cultura do paciente.
- Ψ **É hipótese, não veredito.** Levantada com o paciente e não sobre ele, pode ser refutada ou corroborada; organiza causas, precipitantes e influências mantenedoras.
- Ψ **Amarrar a formulação ao diagnóstico estreita demais.** Dois pacientes com o mesmo rótulo podem ter processos mantenedores e contextos completamente distintos — e por isso pedem intervenções distintas.
- Ψ **Avaliação integral antes da rede.** Cognição, afeto, atenção, self, motivação e comportamento, atravessados pelos níveis biofisiológico e cultural, com o contexto como variável ativa — não como pano de fundo.
- Ψ **Sem plano de tratamento, a formulação vira exercício.** Hierarquizar os processos centrais com o paciente e converter isso em procedimentos empiricamente sustentados é o que fecha o ciclo.

Formulação de caso e prática baseada em evidências

A aula abriu desfazendo um mal-entendido comum: o de que praticar psicologia baseada em evidências significaria atender apenas casos com diagnóstico fechado e aplicar protocolos rígidos. A prática baseada em evidências (PBE) é mais larga que isso — sustenta-se em **três pilares: a melhor evidência disponível, a expertise clínica, e as preferências, valores e cultura do paciente.**

A formulação de caso é a habilidade que faz esses três pilares se encontrarem no caso concreto. Ela integra dados **nomotéticos** — o que a teoria e os estudos de intervenção dizem sobre grupos — com dados **idiográficos**, que são os desta pessoa. Unir os dois é ao mesmo tempo o desafio e a beleza do processo, e é o que permite adaptar e individualizar o tratamento sem abrir mão do compromisso com a evidência.

Uma ênfase que atravessou o encontro: isso é **treinável**. Não é intuição que alguns têm e outros não. Melhora com prática deliberada, e se ajusta continuamente do início ao fim do tratamento.

Os limites de amarrar a formulação ao diagnóstico

Tratamentos empiricamente sustentados são úteis: oferecem descrições precisas de procedimento e vêm de estudos controlados. O problema aparece quando a formulação de

caso é acorrentada a eles. A prática não é linear, e existe uma quantidade enorme de manuais que repetem procedimentos muito parecidos, organizados por psicopatologia.

Há ainda um risco mais sutil nos modelos puramente descritivos — a conceitualização cognitiva clássica é o exemplo trabalhado. Como focam predominantemente um aspecto do funcionamento, tendem a **circularizar o sofrimento**: descrevem o ciclo com precisão, mas explicam o sintoma pelo diagnóstico e o diagnóstico pelo sintoma. E o paciente não é puramente cognitivo.

MESMO DIAGNÓSTICO, OUTRA CLÍNICA

Dois pacientes com depressão podem ter processos centrais completamente diferentes — um sustentado pela tristeza e pela perda de reforçadores, outro por um pessimismo rígido sobre o futuro. **O rótulo é o mesmo; o que mantém o sofrimento não é.** Aplicar o mesmo protocolo aos dois é tratar a média, não a pessoa.

É daí que vem a TBP — não como uma nova teoria ou uma nova intervenção, mas como **metamodelo**: um jeito de reorganizar os dados que já existem para individualizar o tratamento. A formulação de caso é o fio condutor desse trabalho, e ajuda também na hierarquização quando o paciente chega com várias demandas ao mesmo tempo.

O que é (e o que não é) uma formulação de caso

Formulação de caso é um **processo de desenvolvimento de hipóteses**, não de verdades. O clínico as levanta junto com o paciente, e elas podem ser refutadas ou corroboradas ao longo do trabalho. Elas se organizam em três frentes:

- Ψ **Causas** — o que na história de vida ajuda a entender como o padrão se formou.
- Ψ **Precipitantes** — o que aconteceu antes de a demanda aparecer, ou de ela apertar.
- Ψ **Influências mantenedoras** — os processos psicológicos, emocionais, comportamentais e interpessoais que sustentam o quadro agora.

É um processo vivo. Funciona como um mapa que guia a tomada de decisão em psicoterapia, e a boa formulação é **circunscrita**: não precisa abarcar o mundo inteiro do paciente. Um mapa útil mostra o ponto de partida e o destino — e são os objetivos da terapia que definem quais informações entram.

Suas funções, na prática: organizar a informação; conectar diagnóstico ou sintomatologia às demandas reais; ligar teoria e prática; planejar o tratamento; e fortalecer a relação terapêutica, porque uma compreensão ampla dos processos é, ela própria, validante para quem está do outro lado.

COM O PACIENTE, NÃO SOBRE ELE

A formulação não é uma análise unilateral que o terapeuta faz em casa e apresenta pronta. É co-construída, devolvida, checada — e revisada quando a intervenção não produz o que se esperava. **Pedir feedback não é gentileza: é o mecanismo de correção da hipótese.**

O primeiro passo: avaliação integral

Antes de qualquer rede, avaliação. E avaliação de tudo — porque é a integralidade que protege contra viés e omissão. As **seis dimensões** são cognição, afeto, atenção, self, motivação e comportamento; os **dois níveis** que as atravessam são o biofisiológico e o cultural. O contexto entra como variável ativa da formulação, e não como cenário.

As fontes são as de sempre, usadas com intenção: entrevista clínica com perguntas dirigidas a cada dimensão, observação em sessão, exame do estado mental e instrumentos padronizados.

Para cada processo identificado, três perguntas — que não são etapas em sequência, e sim leituras que transitam ao mesmo tempo durante a sessão:

TRÊS LEITURAS DE CADA PROCESSO**VARIAÇÃO**

Como o comportamento varia — a leitura mais descritiva

→

SELEÇÃO

Para que ele serve: a função que o mantém

→

RETENÇÃO

Como esses processos se mantiveram ligados ao longo do tempo

Não são fases sequenciais: as três transitam simultaneamente ao longo da avaliação.

Dois modelos: a tabela e a matriz

Dentro da TBP, dois formatos organizam o material — e são complementares, não concorrentes.

A TABELA

O metamodelo evolucionário estendido em formato funcional: lista, por dimensão, os processos mal adaptativos e também os recursos e processos preservados do paciente.

A MATRIZ

As dimensões organizadas em quadrantes, com as conexões desenhadas por setas. É onde a análise de rede acontece de fato.

A ORDEM

Listar primeiro, conectar depois. Fazer a matriz sem a listagem prévia tende a produzir uma rede imprecisa e mais difícil de ensinar.

A recomendação prática da apresentação foi essa última: **comece listando os processos, e só então desenhe as setas**. É mais didático para quem está aprendendo e sai mais preciso — ponto em que apresentadora e mediação concordaram durante o encontro.

Maria: da queixa à rede

O caso ilustrativo foi o de Maria, 28 anos, que sente ansiedade e insegurança ao interagir socialmente, com a preocupação recorrente de ser chata ou passar vergonha. O diagnóstico de transtorno de ansiedade social estaria disponível — e a proposta foi justamente ir além dele, perguntando como esses elementos interagem na vida dela.

Cognição e afeto

A insegurança e a ansiedade intensificam a preocupação de ser chata ou passar vergonha; a preocupação, por sua vez, realimenta a insegurança e a ansiedade. Já aí aparece uma alça — e ela ainda não explica o caso sozinha.

Biofisiológico e comportamento

No corpo: aperto no estômago, taquicardia, sudorese, diretamente acoplados aos episódios de insegurança. No comportamento, dois movimentos aparentemente opostos que fazem a mesma coisa — **supercompensação** em alguns contextos (esforçar-se para ser engraçada, agradável) e **evitação** em outros (ficar em casa, não se expor a estranhos ou a figuras de autoridade). Ambos reforçam o ciclo.

Atenção, self e motivação

No atencional, o pensamento “vou me constranger” aparece quase todos os dias, sobretudo antes de conversas com desconhecidos — ruminação e preocupação. No self, conceitos rígidos do tipo “sou chata”, “sou inconveniente”. A motivação foi o ponto que ficou menos claro e precisaria de mais investigação, com a hipótese de estar ligada ao alívio imediato que a evitação produz.

Com o material na mesa, a orientação foi **limitar a rede a um número manejável de processos** — cerca de dez, no exemplo — e então perguntar ao próprio paciente pelas relações causais: quando você pensa isso, o que costuma fazer em seguida? O autorrelato é o que dá substância às setas.

Hierarquizar e transformar em plano

Desenhada a rede, o passo seguinte é identificar quais processos são mais centrais — no caso de Maria, a articulação entre cognição, comportamento e afeto, com destaque para a rigidez dos pensamentos sobre si e para a evitação. Essa hierarquização também é feita com o paciente, apoiada em feedback e em mensuração.

Do mapa nasce o plano, que pode ser organizado numa tabela com quatro colunas: **dimensão · processos mal adaptativos · processos adaptativos a construir · procedimentos empiricamente sustentados**. Para a alta sensibilidade à ansiedade de Maria, por exemplo, o alvo seria aumentar a aceitação, com exposições interoceptivas como procedimento.

A TBP trabalha com núcleos de tratamento comportamentais, contextuais e cognitivos, o que permite um **ecletismo técnico modular** — usar o procedimento que serve ao processo-alvo, venha ele de onde vier, desde que tenha evidência.

SEM PLANO, É SÓ DESENHO

A análise de rede não é o produto final. **Sem um plano de tratamento bem elaborado, a formulação de caso vira exercício de diagrama** — e o objetivo continua sendo o desfecho do paciente, não a elegância do mapa.

Flexibilidade dentro da fidelidade

O ponto levantado na mediação amarra o encontro à discussão maior da PBE. Fidelidade a protocolos nomotéticos, na clínica viva, muitas vezes não se sustenta: os pacientes chegam com múltiplas demandas e comorbidades que o manual não previu. A formulação de caso é o que autoriza deslocamentos sem perder o rigor — permite o olhar idiográfico que acomoda o caso real, vestindo, nas palavras usadas no encontro, a roupa da flexibilidade dentro da fidelidade.

A mensuração entra aqui com dupla função, retomando o encontro anterior: monitorar o tratamento e, principalmente, **validar ou invalidar as hipóteses de relação causal** que a formulação propôs. É o teste da rede.

SOBRE A CURVA DE APRENDIZAGEM

Construir a primeira rede é hipotético e cansativo, e o paciente às vezes responde com incerteza — isso é esperado, não sinal de erro. A fase inicial é a mais trabalhosa e é justamente a que entrega mais clareza; **feito o grosso, os ajustes seguintes tendem a ser pequenos.**

O roteiro, em cinco passos

- Ψ **Avalie por inteiro** — as seis dimensões e os dois níveis, sem pular o que parece pouco relevante.
- Ψ **Identifique os domínios principais** a partir da queixa e dos objetivos combinados.
- Ψ **Faça a análise de rede**, listando antes de conectar. Espere que a primeira versão seja incompleta: é ela que aponta o que ainda falta investigar.
- Ψ **Hierarquize com o paciente**, usando feedback e mensuração para achar os processos mais centrais.
- Ψ **Converta em plano** — dimensão, processo a reduzir, processo a construir, procedimento com evidência — e revise ao longo do tratamento.

Referências

1. APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. (2006). Evidence-based practice in psychology. *American Psychologist*, 61(4), 271–285.
2. Eells, T. D. (2015). *Psychotherapy case formulation*. Washington, DC: American Psychological Association.
3. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment: The conceptual and treatment utility of an extended evolutionary meta-model. *Clinical Psychology Review*, 82, 101908.
4. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., Stanton, C. E., Carpenter, J. K., Sanford, B. T., Curtiss, J. E., & Ciarrochi, J. (2019). The role of the individual in the coming era of process-based therapy. *Behaviour Research and Therapy*, 117, 40–53.
5. Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. *Clinical Psychological Science*, 7(1), 37–50.
6. Hofmann, S. G., Hayes, S. C., & Lorscheid, D. N. (2021). *Learning Process-Based Therapy: A Skills Training Manual for Targeting the Core Processes of Psychological Change in Clinical Practice*. Oakland, CA: New Harbinger. [Ed. bras.: *Aprendendo a Terapia Baseada em Processos*, cap. 5.]
7. Kendall, P. C., & Beidas, R. S. (2007). Smoothing the trail for dissemination of evidence-based practices for youth: Flexibility within fidelity. *Professional Psychology: Research and Practice*, 38(1), 13–20.

8. Persons, J. B. (2008). *The case formulation approach to cognitive-behavior therapy*. New York: Guilford Press.

NOTA DE MÉTODO

O caso “Maria” é ilustrativo, apresentado como tal em aula. Duas observações de conteúdo. Primeira: o encontro trabalhou com a divisão “seis dimensões e dois níveis” (biofisiológico e cultural), tratando o contexto como variável ativa da formulação; a série vinha usando a leitura de nove domínios do EEMM, em que biofisiológico, contexto e sociocultural aparecem como as três dimensões que atravessam os seis processos psicológicos. As duas leituras descrevem o mesmo metamodelo — a diferença está em onde o contexto é alocado —, e aqui foi preservada a formulação usada pela apresentadora. Segunda: a aula não citou fontes nominalmente. As referências listadas foram acrescentadas por mim como apoio de estudo, cobrindo os pontos que o encontro tratou — os três pilares da PBE (APA, 2006), a tradição de formulação de caso (Persons, 2008; Eells, 2015), o metamodelo e a virada por processos (Hofmann & Hayes, 2019; Hayes et al., 2019, 2020) e o conceito de flexibilidade dentro da fidelidade (Kendall & Beidas, 2007). A divulgação do clube do livro feita ao final não foi incluída no resumo.

contato@psicojulio.com · (47) 99933-8021

Rua Concórdia, 703, São Vicente, Itajaí — 88309-645 · CNPJ 49.649.803/0001-60

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

- ☐ Avaliei as seis dimensões e os dois níveis antes de desenhar qualquer seta — inclusive as que pareciam pouco relevantes.
- ☐ Para cada processo, perguntei variação, seleção e retenção — não só o que acontece, mas para que serve.
- ☐ Listei os processos primeiro e só depois construí a rede.
- ☐ Limitei a rede a um número manejável de processos, guiado pelos objetivos da terapia.
- ☐ Devolvi a formulação ao paciente e perguntei se as relações causais fazem sentido para ele.
- ☐ Converti a rede num plano com processo-alvo e procedimento correspondente — e marquei quando vou revisar.

MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

1. Quais são os três pilares da prática baseada em evidências, e como a formulação de caso os articula num caso concreto?

2. O que diferencia uma hipótese de formulação de uma explicação diagnóstica — e o que é “circularizar o sofrimento”?

3. Explique variação, seleção e retenção com um exemplo de um paciente seu.

4. Por que a recomendação é listar os processos antes de desenhar a matriz de rede?

5. O que significa “flexibilidade dentro da fidelidade”, e que problema clínico esse conceito resolve?

6. Pegue um caso seu e escreva as quatro colunas do plano para um único processo-alvo: dimensão, processo mal adaptativo, processo adaptativo a construir e procedimento.